



En un país que envejece: Análisis de la utilización de servicios de salud en Chile.

Informe de avance 1

Elisa Calderón

Amalia Tsukame

Departamento de Sociología, Universidad de Chile

ORCID: 0009-0001-0171-7199 | 0009-0004-3578-1289

Profesor guía:

Santiago de Chile

10 de septiembre de 2026

Tabla de contenidos

Abstract	1
1 Definición del problema	3
1.1 Objeto de estudio	4
1.2 Pregunta de investigación	4
2 Revisión inicial de literatura	5
3 Propuesta metodológica	7
3.1 Disponibilidad de datos	8
4 Referencias bibliográficas	9

Abstract

El envejecimiento poblacional constituye una de las principales transformaciones demográficas que enfrenta Chile y plantea nuevos desafíos para la organización y utilización del sistema de salud. El aumento de la población de mayor edad no implica únicamente un incremento en el número de personas que requieren atención, sino también una posible transformación en los patrones de utilización de los servicios, asociada a cambios en las necesidades de salud, la prevalencia de enfermedades crónicas y las condiciones sociales y territoriales en que se produce el acceso a la atención. En este contexto, resulta relevante analizar el envejecimiento no solo como un fenómeno demográfico, sino también en relación con la forma en que las instituciones sanitarias organizan y median la respuesta frente a dichas necesidades.

Esta investigación busca analizar la relación entre la estructura etaria de la población chilena y los patrones de utilización de los servicios de salud, considerando las condiciones sociales e institucionales que intervienen en dicha relación. Desde una perspectiva sociológica, se propone comprender el sistema de salud como una institución que estructura oportunidades diferenciadas de acceso y utilización, particularmente en un contexto caracterizado por la segmentación entre FONASA e Isapres. Para organizar analíticamente estos factores se utilizará como referencia el modelo conductual de utilización de servicios de salud de Andersen, distinguiendo factores predisponentes, facilitadores y de necesidad.

Empíricamente, se utilizará la Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN) 2024 para estimar, mediante modelos de regresión logística binaria, la relación entre edad, características sociodemográficas, condiciones de acceso y necesidad de salud y la utilización de distintos servicios, tales como atención médica general, atención de especialidad y hospitalización. El análisis considerará además las diferencias asociadas a

la adscripción previsional y otras condiciones sociales y territoriales. Finalmente, a partir de los patrones estimados y de las proyecciones de población del Instituto Nacional de Estadísticas (INE), se evaluará la factibilidad de desarrollar escenarios de proyección o microsimulación que permitan explorar cómo la transformación futura de la estructura etaria podría modificar los patrones de utilización del sistema de salud.

Palabras clave: Sociología, Chile, Envejecimiento poblacional, Sistema de salud chileno, Modelo conductual de Andersen, Encuesta CASEN.

1 Definición del problema

En la actualidad, Chile atraviesa un sostenido y avanzado proceso de envejecimiento poblacional que está modificando la estructura por edades de la población. Los resultados del Censo 2024 muestran que la población de 65 años y más representa el 14 % de la población nacional, mientras que en 1992 era un 6,6 %. En paralelo, ha disminuido el porcentaje de personas de 14 años o menos de 29,4 % a 17,7 % en el mismo período. Con lo anterior, el Índice de Envejecimiento muestra que por cada 100 personas de 14 años o menos hay 79 personas de 65 años o más en el país, cifra que para el año 1992 era 22,3. Adicionalmente, el 11,6 % de los hogares a nivel nacional están conformados solo por personas de 65 años o más. Esta cifra era 8,3 % en 1992 ([Instituto Nacional de Estadísticas, 2025](#)). Las nuevas proyecciones del INE indican que este proceso seguirá profundizándose en las próximas décadas, de manera que para 2045, la población de 65 años y más triplicaría a la población menor de 15 años ([Instituto Nacional de Estadísticas, 2024](#)).

Este proceso plantea interrogantes y desafíos respecto de las demandas futuras que podrían enfrentar las instituciones, y en particular el sistema de salud. La relación entre envejecimiento poblacional y la utilización del sistema de salud no se puede reducir a que las personas mayores utilizarán más los servicios de atención médica. Si bien la edad cronológica se relaciona con cambios en la salud, presencia de enfermedades o limitaciones funcionales, estos no se distribuyen de manera homogénea en la población, sino que están sujetos a condiciones socioeconómicas, educativas, culturales y territoriales.

Desde una perspectiva sociológica, el envejecimiento constituye, por tanto, un fenómeno que debe ser comprendido en relación con las desigualdades sociales acumuladas a lo largo de la vida. Personas de la misma edad pueden presentar diferentes condiciones de salud y distintas posibilidades de acceder a los servicios sanitarios. En este marco, el problema de investigación se sitúa en la necesidad de comprender cómo se relaciona la edad con la utilización de distintos servicios de salud en Chile y en qué medida esta relación se encuentra condicionada por las necesidades de salud y por factores sociales y estructurales que facilitan o dificultan el acceso.

Comprender esta relación permite caracterizar las diferencias actuales en el uso de servicios de salud, y aproximarse a los posibles cambios futuros en la demanda sanitaria que traerá el envejecimiento poblacional.

1.1. Objeto de estudio

El objeto de estudio corresponde a la utilización de servicios de salud en el contexto del envejecimiento poblacional.

1.2. Pregunta de investigación

A partir de lo anterior, se formula la siguiente pregunta de investigación:

¿Cómo se relaciona el envejecimiento con la utilización de los servicios de salud en Chile y en qué medida esta relación se modifica según las necesidades de salud y las condiciones sociales, económicas, institucionales y territoriales de las personas?

2 Revisión inicial de literatura

La investigación se sitúa inicialmente en la intersección de cuatro campos conceptuales: el envejecimiento poblacional, las desigualdades sociales en salud, las instituciones y la utilización de servicios sanitarios.

En relación al envejecimiento demográfico, este es definido como el aumento progresivo de la proporción de personas mayores, producto de la evolución conjunta de fecundidad y mortalidad ([Comisión Económica para América Latina y el Caribe, s. f.](#)). Desde una perspectiva individual y biológica, el envejecimiento implica cambios graduales de las capacidades físicas y mentales, y un mayor riesgo de enfermedad ([Organización Mundial de la Salud, s. f.](#)). Sin embargo, para esta investigación, el envejecimiento se aborda como proceso que se desarrolla a lo largo del curso de vida, por lo que la edad es una dimensión relevante pero no suficiente para explicar las diferencias en las condiciones de salud y la utilización de los servicios médicos.

En este sentido, y bajo el marco de los determinantes sociales de la salud, se señala que las personas que logran una mejor posición social tendrán menos probabilidades de estar expuestos a enfermedades y en caso de enfermar, tendrán mejores posibilidades para afrontarlo y sufrir menores consecuencias sociales y económicas ([Moscoso Cuaresma et al., 2017](#)). Por ello, las desigualdades acumuladas a lo largo del curso de vida pueden contribuir a que personas de una misma edad presenten diferentes necesidades de salud y distintas posibilidades de acceder a atención sanitaria.

Estas diferencias son relevantes al considerar el rol de las instituciones, ya que estas constituyen mecanismos desde el cual se canalizan las demandas de grupos vulnerables y se sostiene la cooperación colectiva ([Huenchuan, 2016](#)). En este marco, el sistema de salud representa la institución central para responder a las necesidades sanitarias de la población. Sin embargo, la forma en que se organizan y distribuyen los recursos institucionales puede contribuir a facilitar o restringir las posibilidades de acceso de distintos grupos sociales.

Para organizar analíticamente estos factores, se utilizará el Modelo Conductual del Uso de los Servicios de Salud de Andersen, el cual sugiere que “el uso de los servicios de salud por parte de las personas depende de su predisposición a utilizarlos, así como de factores que facilitan o dificultan su uso y la necesidad de atención médica” (2008, p. 651). Para esto, desarrolla tres grupos de factores: factores predisponentes, los que corresponden a características individuales y sociales que anteceden a la utilización y que estructuran la propensión a utilizar servicios; factores facilitadores, los cuales representan recursos y condiciones que pueden permitir o dificultar la utilización; factores de necesidad que representan las condiciones que hacen necesaria o potencialmente necesaria la utilización de servicios.

3 Propuesta metodológica

La investigación tendrá un enfoque cuantitativo, observacional y transversal. Se utilizará como fuente principal de datos la [Encuesta de Caracterización Socioeconómica Nacional \(CASEN\) 2024](#), desarrollada por el Ministerio de Desarrollo Social y Familia. La encuesta recopila información sobre aspectos demográficos, módulos de salud, educación, vivienda, trabajo e ingresos, que permite conocer periódicamente la situación de los hogares y de la población, especialmente de aquella en situación de pobreza y de aquellos grupos definidos como prioritarios por la política social, además, de evaluar el impacto de la política social ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024](#))

La unidad de análisis de esta investigación corresponde a las personas residentes en los hogares particulares encuestados por la CASEN 2024. La encuesta contempla un total de 218.367 personas, pertenecientes a 78.654 hogares y 77.618 viviendas ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024](#)). Para efectos de esta investigación, se utilizará como referencia la muestra de personas, mientras que el número de observaciones efectivo podrá variar entre los distintos modelos de acuerdo con el universo específico de cada variable, la aplicación de filtros y la disponibilidad de información.

Las variables dependientes serán indicadores de utilización de servicios de salud: atención de medicina general en los últimos tres meses, atención de especialidad en los últimos tres meses y hospitalización o intervención quirúrgica en los últimos doce meses.

Las variables independientes serán organizadas en función del Modelo Conductual de Andersen. En donde, en primer lugar, las variables predisponentes (edad, sexo, nivel educacional y estado civil) dan cuenta de las características demográficas y sociales que pueden condicionar la propensión individual a utilizar servicios de salud. En segundo lugar, las variables facilitadoras o de acceso (sistema previsional, ingreso per cápita del hogar, región y área de residencia, y proximidad al centro de salud) reflejan los recursos materiales e institucionales que habilitan o restringen el acceso efectivo a la atención. En tercer lugar, las variables de necesidad capturan

condiciones de salud que pueden generar la búsqueda de atención como son las condiciones de larga duración y limitaciones funcionales.

En relación al análisis, se utilizarán modelos de regresión logística binaria para estimar la probabilidad de utilización de cada tipo de servicio. Se propone una estrategia de modelos anidados. Un primer modelo incorporará las características predisponentes y permitirá observar la asociación inicial entre edad y utilización. Un segundo modelo añadirá las variables de necesidad para analizar en qué medida la asociación con la edad se modifica al considerar diferencias en el estado de salud. Finalmente, un tercer modelo incorporará los factores facilitadores, permitiendo evaluar la asociación de los recursos económicos, institucionales y territoriales con la utilización, una vez consideradas las características predisponentes y las necesidades de salud.

3.1. Disponibilidad de datos

Los datos utilizados en esta investigación corresponden a la Encuesta CASEN 2024, cuya base de datos y documentación metodológica son de carácter público y de libre acceso. El Ministerio de Desarrollo Social y Familia, a través del Observatorio Social, pone a disposición de la ciudadanía la base de microdatos (en formato SPSS, Stata y CSV), el libro de códigos, el diccionario de variables, la ficha técnica y el manual de aplicación del cuestionario, entre otros documentos metodológicos, sin requerir solicitud de acceso ni autorización previa ([Ministerio de Desarrollo Social y Familia, 2024](#)).

4 Referencias bibliográficas

- Andersen, R. M. (2008). National Health Surveys and the Behavioral Model of Health Services Use. *Medical Care*, 46(7), 647-653.
- Comisión Económica para América Latina y el Caribe. (s. f.). *Acerca de Envejecimiento CEPAL*. Recuperado <https://www.cepal.org/es/temas/envejecimiento/acerca-envejecimiento>
- Huenchuan, S. (2016). *Envejecimiento e institucionalidad pública en América Latina y el Caribe: conceptos, metodologías y casos prácticos*. Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL). <https://www.cepal.org/es/publicaciones/40197-envejecimiento-institucionalidad-publica-america-latina-caribe-conceptos>
- Instituto Nacional de Estadísticas. (2024). *Estimaciones y Proyecciones de Población 1992-2070, Base 2024: Presentación de Resultados*.
- Instituto Nacional de Estadísticas. (2025). *Primeros resultados del Censo 2024: 18.480.432 personas fueron censadas en Chile, manteniéndose la tendencia de envejecimiento de la población*. <https://censo2024.ine.gob.cl/primeros-resultados-del-censo-2024-18-480-432-personas-fueron-censadas-en-chile-manteniendose-la-tendencia-de-envejecimiento-de-la-poblacion/>
- Ministerio de Desarrollo Social y Familia. (2024). *Informe metodológico Casen 2024*.
- Moscoso Cuaresma, J. R., Cárdenas, E., & Juárez, C. (2017). *Determinantes Sociales en Salud*. Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas. https://www.researchgate.net/profile/Julio-Ricardo-Moscoso-Cuaresma/publication/385822723_Determinantes_sociales_en_salud/links/6736a966a78ba469f0617e2a/Determinantes-sociales-en-salud.pdf
- Organización Mundial de la Salud. (s. f.). *Envejecimiento y salud*. Recuperado <https://www.who.int/es/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health>